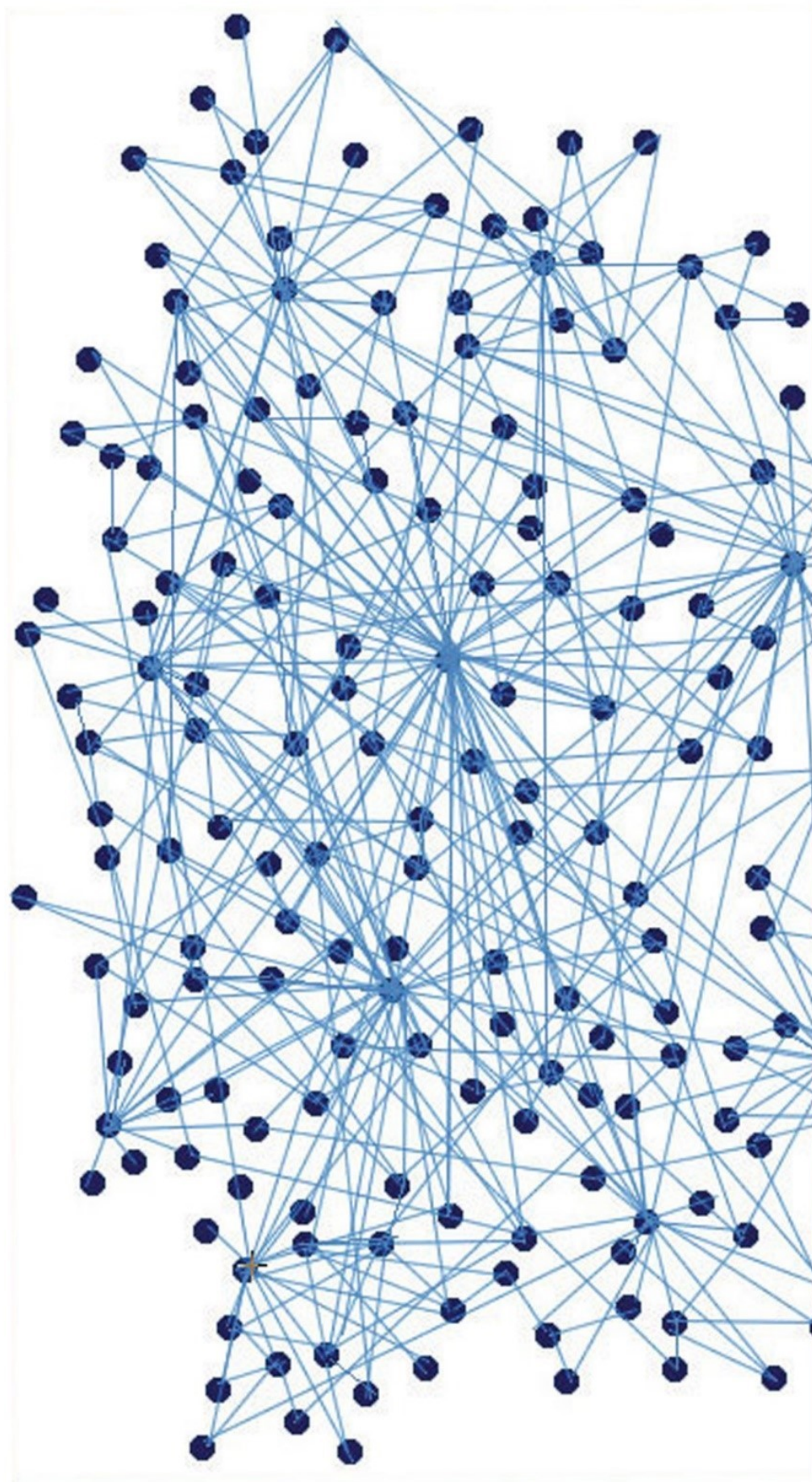




Irene Petruccelli - L'approccio strategico alla comunicazione



**Università
Mercatorum**

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

Indice

1. INTRODUZIONE.....	3
2. TITOLO LE TECNICHE D'INTERVENTO.....	7
3. L'AZIONE UMANA COMUNICATIVA.....	18
BIBLIOGRAFIA.....	22

1. Introduzione

L'approccio strategico, alla stregua di quanto sostenuto dal **costruttivismo sociale**, ritiene gli individui soggetti attivi nella costruzione della propria realtà attraverso la continua negoziazione di significati all'interno delle interazioni con gli altri e con il contesto di riferimento.

La comunicazione rappresenta il punto cardine dell'approccio in quanto responsabile del modo in cui la persona percepisce sé stessa, gli altri, le relazioni ed i contesti; dunque, del modo in cui la realtà viene costruita, così da risultare unica e prettamente soggettiva.

Si parla, dunque, di un'assoluta autodeterminazione della persona, soggetto che agisce e non subisce gli eventi, capace di costruire il futuro e responsabile delle proprie scelte.

Partendo da tale presupposto, il linguaggio del terapeuta rappresenta il mezzo di elezione per favorire il cambiamento del punto di vista del cliente, per renderlo consapevole e responsabile della sua esistenza e delle proprie azioni, per aumentarne il numero delle possibili scelte a sua disposizione in modo da trovare nuove soluzioni al problema.

Il cliente non viene considerato un malato bisognoso di cure, bensì un soggetto che presenta un problema; allo stesso modo il suo sintomo non rappresenta l'effetto manifesto della sua malattia, ma

un atto comunicativo che gli permette di relazionarsi con e definire la realtà.

La comunicazione strategica è orientata in direzione di un obiettivo da raggiungere – la de-strutturazione del sintomo – passando per sotto-obiettivi concreti e ragionevoli, stabiliti congiuntamente da terapeuta e cliente. Questi minimi cambiamenti, una volta occorsi, innescano una reazione a catena che finisce per provocare delle modifiche sostanziali nel complesso del sistema di funzionamento della persona.

Una volta stabilito un obiettivo da raggiungere, il compito del terapeuta è di progettare degli interventi per la realizzazione di questo, utilizzare le risposte del cliente per guidare il proprio approccio e, infine, esaminare il risultato della terapia per verificarne l'efficacia.

Il compito del terapeuta si limita a strutturare la forma della propria comunicazione in modo da ottenere la massima collaborazione del cliente e soprattutto stravolgerne l'usuale percezione della realtà, cambiandone il comportamento interattivo e/o l'interpretazione di tale comportamento e delle situazioni relazionale, elementi alla base delle rigidità disfunzionali, in modo da arrivare alla risoluzione del disturbo.

In psicoterapia strategica, al posto di un linguaggio descrittivo e indicativo tipico della spiegazione e della descrizione delle cose e degli eventi, viene adoperato un *linguaggio suggestivo e ingiuntivo* che, attraverso le prescrizioni, induce a eseguire azioni ed esperire emozioni, l'unico in grado di aggirare quella particolare modalità di relazione con il contesto che è alla base della sofferenza e della resistenza al cambiamento.

Inoltre, il linguaggio usato dal terapeuta deve ricalcare quello del cliente di modo da poter addentrarsi nel suo sistema rappresentativo e, quindi, influenzarlo.

Ciò aiuta l'individuo a sentirsi accolto, compreso e aiutato fino a creare un clima di fiducia e collaborazione, punto focale per un esito positivo del trattamento psicoterapico.

L'utilizzo di una comunicazione suggestiva e di precise strategie quali l'uso dei paradossi, delle metafore, della prescrizione del sintomo, delle prescrizioni dirette e indirette di comportamenti apparentemente illogici, ecc. provoca nel cliente delle esperienze percettive concrete, diverse e alternative rispetto a quelle agite fino a quel momento, con lo scopo di fargli provare realmente qualcosa di nuovo, di fargli affrontare la situazione da un punto di vista differente, provocando in lui reazioni emotive e le ristrutturazioni cognitive conseguenti nella percezione della realtà.

Così facendo, si assiste a un cambiamento sia a livello cognitivo che emotivo e comportamentale. Solo dopo che il cambiamento si è realizzato, per lo più inconsapevolmente per il

cliente, lo si fa riflettere su quanto avvenuto; questo si renderà conto, sperimentandolo in prima persona, che è possibile far fronte ai problemi e relazionarsi agli altri in maniera diversa, innovativa e funzionale.

Tale consapevolezza agisce rinforzandolo e modificando le sue competenze individuali e sociali e, dunque, promuovendone la crescita personale.

Secondo l'approccio strategico, in psicoterapia l'uso di un linguaggio ironico, sia a livello verbale che non verbale, piuttosto che di toni troppo seri e drammatici, allevia le sensazioni negative che hanno portato il cliente a chiedere aiuto, gli trasmette la volontà di mettersi in gioco e di interagire, contribuendo a creare un clima di collaborazione e fiducia.

La cura di ogni minimo particolare dell'interazione, l'uso della suggestione e di determinate tecniche d'intervento, permettono al terapeuta di assumere in prima persona la responsabilità di varcare la resistenza al cambiamento al fine di destrutturare la percezione disfunzionale della realtà che genera sofferenza alla persona.

2. Titolo Le tecniche d'intervento

L'approccio strategico alla psicoterapia si realizza all'interno del rapporto tra terapeuta e cliente, in cui il primo ricopre un ruolo piuttosto direttivo nei confronti del secondo e si assume la responsabilità di influenzarlo in modo diretto utilizzando creativamente una serie di strategie predeterminate che si concretizzano in vere e proprie manovre comunicazionali.

Tali tecniche, descritte di seguito, permettono di rompere gli schemi di percezione e reazione alla realtà che hanno portato il soggetto a richiedere l'intervento del terapeuta, ne favoriscono lo sviluppo della capacità di affrontare i problemi futuri e, a un livello più generale, modificano e arricchiscono le sue competenze sociali, basi per sostenere una crescita permanente.

Il loro utilizzo risulta molto efficace quando si lavora con clienti caratterizzati da una sintomatologia definita che permette di fissare in modo chiaro gli obiettivi; tuttavia, anche quando si ha a che fare con problematiche meno circoscritte la definizione di obiettivi specifici risulta comunque necessaria al fine del successo terapeutico (Petruccelli, Parziale, 1999).

Come sottolineato in precedenza, all'interno di una psicoterapia strategica risulta di fondamentale importanza l'uso di un *linguaggio suggestivo*.

Il terapeuta deve avere ben presente i significati multipli che le parole possono assumere, il tono di voce utilizzato e la sequenza nella quale sono inserite.

Secondo Erikson e Rossi (1981), risulta essenziale impiegare parole che si associno agli interessi della singola persona, servirsi di terminologie e pause in modo appropriato in base al cliente che si ha davanti, fare uso della negazione che stimola inconsapevolmente l'elaborazione del contrario di quanto affermato dalla negazione stessa.

In ogni caso, il ricorso al linguaggio suggestivo varia durante il trattamento terapeutico, risultando più massiccio durante le prime sedute dove occorre agganciare il cliente.

La *tecnica del ricalco* (Bandler, Grinder, 1975), ovvero l'utilizzo del linguaggio e del modo in cui la persona si rappresenta e si relaziona con sé stesso e con la realtà (Nardone, 1991), risulta di estrema importanza per catturare il cliente e aggirare le sue resistenze.

Quando si ha davanti una persona poco collaborativa, con difficoltà a parlare in modo diretto del proprio problema, l'uso di metafore e finzioni comunicative gli consente di aprirsi, se pur in modo indiretto (Haley, 1985).

La tecnica del ricalco si esplica anche nel *riprodurre la comunicazione non verbale*, le posture ed i movimenti del cliente che in tal modo si sentirà maggiormente accolto e rilassato (Nardone, 1991); è, inoltre, necessario che il terapeuta mantenga uno sguardo diretto e costante sul soggetto (*ibidem*).

La comunicazione indiretta si realizza facendo ricorso al *linguaggio analogico* fatto di *aneddoti, metafore e aforismi* dal forte potere evocativo e suggestivo.

Si tratta di una modalità di comunicazione che, attraverso i processi della proiezione e dell'identificazione, minimizza la resistenza del cliente; il messaggio velato che gli giunge non implica richieste o opinioni dirette circa il suo comportamento e le sue idee (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1991; Haley, 1973). Utilizzando questa tecnica, il racconto viene disseminato di metafore, suggestioni, enigmi, indovinelli, giochi associativi che, pur non coinvolgendo direttamente il cliente, producono confusione nei suoi processi mentali fino a una vera e propria frattura nel suo sistema concettuale e comportamentale, a cui consegue uno stato di attivazione interiore (Erickson, Rossi, 1989). Secondo Haley (1963; 1985) l'efficacia dell'uso dell'analogia si riscontra nel fatto che il cliente diviene consapevole del suo problema rifiutandosi di riconoscerlo in modo diretto.

La *tecnica della ristrutturazione* consente di cambiare lo sfondo concettuale ed emozionale in cui il cliente colloca il suo disagio, ponendolo all'interno di una cornice alternativa dove la situazione problematica può trovare una spiegazione perfino migliore (Watzlawick *et al.*, 1974).

Lo spostamento del punto di osservazione permette al cliente di ricodificare le immagini e le percezioni della realtà, ottenendo così un'alterazione del significato che le viene attribuito (Gulotta, 1997). La ristrutturazione consente di mutare la realtà di secondo ordine – i significati ed il valore attribuito alla propria realtà – mantenendo immutata la realtà di primo ordine – i fatti concreti (Watzlawick *et al.*, 1974).

Dal momento che l'esistenza del problema è intimamente associata alla prospettiva di colui che ne denuncia la sofferenza, se il problema può esser visto e vissuto in maniera alternativa, allora può essere ridotto o eliminato.

Lo spostamento di prospettiva viene realizzato mediante paradossi, dubbi ipotetici, storie e metafore, punti di vista alternativi, manovre che sorprendono e conducono ad un cambiamento nel sistema percettivo-reattivo della persona (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1991) oppure attraverso analogie terapeutiche e sillogismi informali (Erickson, Rossi, 1989).

La *tecnica del paradosso* permette di modificare la rigidità percettiva e reattiva attraverso azioni e comunicazioni paradossali illogiche e impreviste che producono quel salto di livello logico alla base del cambiamento auspicato.

Ad esempio, è possibile amplificare le fissazioni e le lamentele del cliente tanto da portarlo a rassicurare il terapeuta stesso (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1991).

Quando si lavora con una persona che si oppone con tenacia al cambiamento si fa ricorso alla *tecnica della resistenza*.

La resistenza prescritta diviene adempimento, mentre le sue funzioni prioritarie vengono annullate (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1991; Erickson, Rossi, 1981; Haley, 1973).

Secondo l'ottica strategica, la resistenza deve essere ascoltata e il terapeuta, utilizzando tutto ciò che viene portato dall'individuo, tende a interpretare tutti i suoi comportamenti come messaggi che offrono un'importante informazione retroattiva e di correzione dell'intervento.

In tal modo la distinzione tra resistenza e cooperazione perde di significato.

Attraverso la *tecnica dell'illusione di alternative* il clinico propone al cliente due alternative tra cui scegliere che in realtà producono il medesimo risultato, creando l'illusione che esistano solo queste due possibilità.

Le due alternative rappresentano solamente un polo di una coppia di opposti più generali e l'individuo viene reso incapace di vedere l'esistenza di altre possibilità.

Si fa spesso ricorso a questa tecnica quando si prescrive al cliente qualcosa che si teme non sarà eseguita.

In questi casi gli viene data la possibilità di scegliere tra eseguire un compito molto ansiogeno e ritenuto impossibile da agire e uno meno ansiogeno e più attuabile, sul quale probabilmente ricadrà la scelta (Nardone, 1991).

In tal modo la persona è obbligata ad assumere un impegno che sarebbe stato rifiutato se fosse stato assegnato come unico compito possibile.

La *tecnica della sorpresa* permette di superare la resistenza del soggetto attraverso l'inserimento di un elemento inaspettato all'interno dello scambio comunicativo (Erickson, Rossi, 1981).

La *tecnica dell'utilizzazione* nasce all'interno del contesto ipnotico per venir poi estesa alla situazione terapeutica in cui non avviene la formale induzione della *trance*; permette di accompagnare l'individuo nell'induzione ipnotica mediante lo sfruttamento di tutti i comportamenti che ha agito (Haley, 1963; Erickson, Rossi, 1981), inclusi la resistenza ed il sintomo, considerati come la migliore scelta possibile del cliente, necessariamente caratterizzato da una percezione della realtà distorta e da una possibilità di scelta limitata.

La *tecnica dell'accettazione del silenzio* vuole sottolineare il significato di attivazione del processo inconscio insito nella posizione di silenzio in cui si pone il cliente (Erickson, Rossi, 1981).

Nella *tecnica di anticipazione delle reazioni e delle espressioni*, il terapeuta previene le azioni del soggetto e anticipa le sensazioni che proverà durante il racconto dei suoi problemi allo scopo, rispettivamente, di obbligarlo ad affermare ciò che si sta dichiarando e di creare in lui l'impressione di potergli leggere nella mente, con l'effetto di acquisire grande potere d'intervento (Nardone, 1991).

La *tecnica di incoraggiamento di una risposta frustrandola* è tesa a incoraggiare un contributo spontaneo da parte del cliente caratterizzato da forte resistenza.

In concreto, il terapeuta chiede al soggetto di mettere in atto un determinato comportamento e lo interrompe appena questo inizia a farlo, passando ad un altro argomento.

Alla seconda richiesta, la risposta risulta migliore in quanto il cliente ha avuto modo di svilupparla, pur avendo subito la frustrazione di essere stato interrotto in precedenza (Haley, 1973).

Nella *tecnica della confusione* il terapeuta va a creare uno stato di confusione mentale nel cliente ponendogli una serie rapida di domande assurde e non pertinenti al contesto di discussione, mostrando un atteggiamento serio e, nel frattempo, comunicando alcuni messaggi molto chiari e concreti a cui il soggetto si aggrappa come l'unico appiglio comprensibile.

Tali messaggi, che in realtà veicolano contenuti problematici, vengono in tal modo acquisiti (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1991).

Con la *tecnica dell'offerta di alternative peggiori* il terapeuta pone una richiesta talmente poco desiderabile che il cliente è costretto a optare per un'alternativa più soddisfacente; così facendo gli viene concesso un margine di autonomia nel prendere decisioni e nel trovare nuovi modelli di comportamento (Haley, 1973).

La *tecnica della dichiarazione d'impotenza* risulta particolarmente indicata con quei soggetti che, invece di pensare a migliorare il proprio comportamento, sono maggiormente interessati a vanificare il lavoro del loro terapeuta.

Il cliente cerca di sabotare ogni tipo di intervento che gli viene proposto e l'unica soluzione a disposizione del clinico è ammettere la propria incapacità nel riuscire a facilitare il cambiamento.

Il cliente reagisce a tale dichiarazione con stupore e con il timore di essere abbandonato, fino a riconoscere la propria responsabilità nel mancato cambiamento. In tal modo il terapeuta acquista potere sulla relazione sfidando la persona ad impegnarsi affinché lo convinca che egli è capace di fare un vantaggioso uso del trattamento (Gulotta, 1997).

La *tecnica della concretizzazione* consiste nel fornire al cliente che formula la sua problematica in maniera troppo generica una serie consistente di esempi concreti che gli consentano di inquadrare in modo più chiaro la questione (Schein, 1987).

Le *prescrizioni comportamentali* rivestono un ruolo di rilievo all'interno del modello strategico, in quanto permettono al soggetto di sperimentare cambiamenti comportamentali concreti che rompono i circoli di azione, di retroazione e le tentate soluzioni che mantengono il problema.

Il terapeuta può impartire una prescrizione all'interno di un contesto comunicativo fortemente suggestivo.

Si possono distinguere prescrizioni dirette, con cui si assegna al soggetto un compito specifico; prescrizioni indirette, che utilizzano lo spostamento del sintomo attirando l'attenzione del soggetto su una diversa problematica, allo scopo di ridurre l'intensità del disturbo presentato; prescrizioni paradossali, che utilizzano la prescrizione del sintomo creando la situazione paradossale di dover eseguire volontariamente ciò che è involontario (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1991; Erickson, Rossi, 1981).

Incoraggiando il comportamento sintomatico, il terapeuta ne ottiene il controllo per poi modificare le istruzioni (Haley, 1963).

L'uso dell'*ironia* all'interno del contesto psicoterapico ha una fondamentale rilevanza nel ristrutturare quelle situazioni che, viste nella loro serietà, verrebbero vissute come inaccettabili e immutabili.

Una ristrutturazione ironica permette di cambiare la cornice percettiva e le conseguenti reazioni del cliente nei confronti di tale realtà (Nardone, 1991).

L'umorismo in terapia ha effetti sia a breve che a lungo termine. Nell'immediato del contesto terapeutico, può servire ad alleviare la tensione, a sdrammatizzare una situazione, ad esorcizzare la paura, a creare un clima di collaborazione, ad evitare la mitizzazione del terapeuta, a far accettare ciò che è proibito, a trasferire concetti altrimenti ostici.

A lungo termine, l'umorismo può consentire al cliente di riflettere sui propri problemi in maniera diversa e creativa, aumentandone così la capacità stessa di risolvere i problemi.

Con i soggetti poco propensi all'umorismo o in situazioni particolarmente difficili è preferibile proporre l'immaginazione di situazioni divertenti (Gulotta, 1997).

Le tecniche fin qui illustrate vanno adattate alle diverse tipologie di clienti.

Con i clienti collaborativi non c'è bisogno di fare ricorso a tecniche particolari, bensì è sufficiente adottare un linguaggio logico descrittivo.

I soggetti parzialmente collaborativi presentano una particolare difficoltà ad abbandonare i loro stili di comportamento.

L'uso del linguaggio e delle tecniche strategiche permette di fare breccia nel loro rigido sistema percettivo, di far emergere le loro nascoste risorse individuali e sociali, di aiutarli a pensare ed a comportarsi in modo diverso, in altre parole di attuare il cambiamento.

I clienti oppositivi mostrano una chiara chiusura nei confronti del terapeuta e di ogni suo tentativo di intervento.

Il terapeuta strategico, per far presa sul cliente, fa ricorso alla comunicazione paradossale e alla creazione dei doppi legali in modo da poter utilizzarne almeno la resistenza.

Invitando il cliente ad essere oppositivo, questo viene posto dinanzi ad una scelta, perseverare in un atteggiamento oppositivo che perde però la sua qualità di squalifica in quanto frutto di una collaborazione con il terapeuta, oppure opporsi alla proposta eliminando così la resistenza iniziale. Qualunque sia la scelta, il terapeuta riesce a ottenere la collaborazione della persona.

Con i clienti inibiti, che hanno una difficoltà oggettiva nell'aprirsi, piuttosto che una volontaria e chiara opposizione alla terapia, il terapeuta deve muoversi con cautela affinché il soggetto possa sentire protette le sue inibizioni per poi lavorarci sopra al fine di diminuirle.

3. L'azione umana comunicativa

Prima di procedere con l'analisi dell'azione umana è utile soffermarci sulla definizione e sui rapporti che intercorrono tra questa e il comportamento.

Come spiegano De Leo e collaboratori (2004), la nozione di comportamento, generalmente considerata sinonimo della nozione di azione, ne costituisce l'aspetto osservabile, mentre l'azione rappresenta un comportamento dotato di significato e di intenzione.

L'essere umano partecipa alla propria azione non solo mettendola in atto, ma anche a un livello prettamente psicologico in quanto la produce e la orienta in modo congruente ai propri scopi, ne anticipa le conseguenze e ne segue i successivi sviluppi.

L'azione, concepita come un comportamento volontario e motivato, risulta essere (Von Cranach, Valach, 1983):

- consapevolmente pianificata;
- diretta a uno scopo;
- accompagnata da emozioni;
- condotta e controllata socialmente.

Inoltre, l'azione della persona, considerata agente sociale, è un *atto sociale* (Harré, 1982) significativamente connesso con i significati e le regole sociali che lo dotano di senso in quanto richiamano un sistema condiviso di impegni e aspettative, che non sono altro che i criteri costitutivi dell'atto sociale stesso in termini di conseguenze trasformative della realtà sociale e, al suo interno, della relazione tra il soggetto e gli altri.

La conoscenza che l'attore ha di tale sistema va a costituire il contenuto delle regole interpretative e prescrittive che lo guidano nel corso delle sue azioni.

In altre parole, il significato risulta il prodotto dell'agentività umana (Harré, 1993). In modo più schematico si può riassumere che (*ibidem*):

1. le azioni sono i significati dei movimenti e delle espressioni;
2. gli atti sono i significati delle azioni;
3. gli impegni e le aspettative sono i significati degli atti.

Von Cranach e Harré (1982), all'interno del teorema *Goal-directed-action* (Azione diretta allo scopo o GDA), descrivono l'azione come un triangolo concettuale in cui ogni lato rappresenta un livello che si interconnette con gli altri realizzando interazioni gerarchiche e retroattive.

Le tre dimensioni della GDA sono:

1. il *comportamento osservabile* o corso manifesto, che corrisponde al comportamento agito e definito da scansioni temporali e spaziali in cui è possibile riscontrare una tappa iniziale, delle tappe processuali e una tappa finale, e da organizzazioni gerarchiche che ne rappresentano i diversi livelli di consapevolezza (De Leo *et al.*, 2004);
2. le *cognizioni coscienti*, equivalenti ai piani d'azione, agli scopi o obiettivi, alle strategie, alle intenzioni, ai valori e alle emozioni con cui il soggetto prepara e porta avanti l'azione, guidano il comportamento sociale a livello sia conscio che inconscio (*ibidem*).
3. i *significati sociali* (situazionali) o definizioni contestuali, ovvero tutto l'insieme di conoscenze riferite all'azione, come le regole e le norme, che sottolineano l'importanza del contesto in cui l'azione viene agita e che confluiscono nel livello del controllo. I significati sociali permettono di collegare l'individuale ed il sociale in quanto consentono di comprendere il senso dell'azione sia nei termini più ampi della cultura di riferimento, che in quelli più circoscritti di una determinata situazione (*ibidem*).

Il significato sociale dà origine alle cognizioni coscienti che, in parte, guidano il comportamento manifesto delle azioni finalizzate ad uno scopo. In altre parole, la società, in una certa misura, produce e vigila sulle azioni dell'individuo per mezzo del controllo delle sue cognizioni; il soggetto, all'interno di questa interazione circolare e retroattiva, a sua volta modifica le strutture sociali attraverso le proprie azioni (Von Cranach, Ochsenein, 1994).

Dunque, lo scopo dell'azione ha continui rinvii di significato in quanto è generato dalla perpetua dinamica circolare e retroattiva tra l'individuo ed il suo comportamento.

Le azioni agite dai singoli soggetti, anche quelle che appaiono non pianificate, hanno sempre uno scopo personale che può essere implicito o esplicito.

Allo stesso tempo, vengono considerate degli eventi sociali in quanto vengono messe in atto in risposta alle azioni altrui, ma assumono anche una direzione anticipatoria e simbolica rispetto alla reazione che l'individuo si aspetta che gli altri agiranno in conseguenza alla sua azione.

Appare chiara la natura interattivo-relazionale delle azioni sociali che divengono delle convenzioni all'interno del sistema sociale condiviso di comunicazione (De Leo *et al.*, 2004).

Le ragioni dell'agire sono, dunque, fortemente collocate all'interno del contesto socio-culturale di riferimento in cui il soggetto negozia nuove forme regolative di rapporto riadattandovi di continuo le regole e accordandovi il significato dell'azione.

Come sottolinea Smorti (2003), la trasformazione dei significati creativi in una forma socialmente comunicata avviene per mezzo delle interpretazioni condivise di una comunità, o comunità interpretativa, in un determinato momento storico.

Tali interpretazioni condivise permetteranno la comparsa e l'integrazione di altri significati all'interno di quella società, che diverranno a loro volta intersoggettivi e comunicabili.

Le interazioni tra esseri umani si basano su scambi relazionali composti sia dai comportamenti agiti, interpretativi e contro-agiti dagli attori sociali che vi partecipano e sia dall'informazione, ovvero il contenuto di tali scambi, il tutto all'interno di un processo inevitabilmente circolare.

Le informazioni veicolate confluiscono e vanno ad accrescere il sistema rappresentazionale proprio dei protagonisti dell'interazione.

Questi, contemporaneamente, comunicano e utilizzano l'atto contingente del comunicare per creare i presupposti informativo-relazionali necessari per la prosecuzione dell'atto comunicativo stesso che, in tal modo, viene sottoposto ad una nuova interpretazione psicologica.

In questa ottica è chiaramente ravvisabile la natura comunicativa dell'azione che veicola contenuti informativi e relazionali, questi ultimi definiti dalla modalità con la quale vengono trasmessi i primi.

Ogni comportamento, sia esso attivamente agito o il risultato di una reazione all'atto di un altro, rappresenta una comunicazione sia per il protagonista dell'atto comunicativo che per i suoi interlocutori, in quanto permette di definire sé stessi e cosa si vuole all'interno dello scambio comunicativo.

Von Cranach (1982) critica tale posizione teorica in quanto ritiene che trascuri gli effetti anticipatori del soggetto, limitandosi a sostenere che siano collegati con i significati sociali e con gli obiettivi del comportamento.

Attualmente, la posizione dell'Autore è stata integrata all'interno della prospettiva sistemica e comunicazionale finora esposta con il risultato di ampliare e rendere più complesso lo schema di azione diretta a uno scopo e di interrogarsi sul significato strumentale ed espressivo dell'azione sociale (De Leo, Patrizi, 1999).

Difatti, si ritiene che le cognizioni guidino le azioni sia a livello della consapevolezza verso determinati scopi, sia a livello di latenza intesa come “dimensione generatrice e costitutiva dell’azione sociale rappresentata dall’ordine espressivo” (De Leo *et al.*, 2004; p. 45) non sempre immediatamente individuabile a livello mentale, ma che fa comunque parte dell’intenzionalità dell’azione in quanto la guida in modo silente.

Questa considerazione permette di individuare i due aspetti che orientano l’azione trascurati dalla teoria della GDA di Von Cranach (1982), ovvero gli *effetti pragmatico-strumentali* e gli *effetti espressivo-comunicativi*.

I primi rappresentano gli effetti concreti e manifesti che il soggetto si aspetta che conseguano dall’azione e sono determinati dalla scelta di strategie comportamentali che assicurino determinati vantaggi, mentre i secondi racchiudono il Sé, le regolazioni, le rappresentazioni e le relazioni dell’identità a un livello che può essere più o meno mascherato, dai diversi sé con cui l’individuo si pone nei confronti degli altri e dalle sue attese circa il modo in cui crede che gli altri accolgano il proprio pensiero.

Questa seconda categoria è stata introdotta e affrontata dalla teoria degli atti linguistici (Austin, 1962) e dalla pragmatica della comunicazione della Scuola di Palo Alto (Watzlawick *et al.*, 1967).

Inoltre, nel corso degli anni Novanta, si è assistito a quella che viene definita la *svolta discorsiva* che, con i suoi contributi teorici, ha permesso di considerare il rapporto tra azione e comunicazione sia come discorsi sull’azione sociale (Harrè, Gillet, 1994; De Leo, 1995), sia intendendo le produzioni discorsive come vera e propria azione sociale (Edwards, Potter, 1993; De Grada, Bonaiuto, 2002).

Bibliografia

- Austin J. L. (1962), *How to Do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford, (tr. it. *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova, 1987).
- De Grada E., Bonaiuto M. (2002), *Introduzione alla psicologia sociale discorsiva*, Laterza, Roma-Bari.
- De Leo G. (1995), "Azione comunicativa e gruppo come contesti pragmatici nelle strategie di cambiamento", in Pagliaro G., Cesa-Bianchi M. (a cura di), *Nuove prospettive in psicoterapia e modelli interattivo-cognitivi*, Franco Angeli, Milano.
- De Leo G., Bollea G. (1984), "Il parricidio in età evolutiva", *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, 1984, I (51): 19-31.
- De Leo G., Mazzei D. (1989), "Per un'analisi sistematica dell'azione violenta", *Terapia familiare*, 30: 21-35.
- De Leo G., Patrizi P. (1999), *La spiegazione del crimine. Un approccio psicosociale alla criminalità*, Il Mulino, Bologna.
- De Leo G., Patrizi P. (2002), *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma.
- De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E. (2004), *L'analisi dell'azione deviante*, Il Mulino, Bologna.
- Edwards D., Potter J. (1993), "Language and causation: A discursive action model of description and attribution", *Psychology Review*, I (100): 23-41.
- Erickson M. H., Rossi E. (1981), *Experiencing hypnosis therapeutic approaches to altered states*, Irvington Publisher, New York, (tr. it. *L'esperienza dell'ipnosi. Approcci terapeutici agli stati alterati*, Astrolabio, Roma, 1985).

- Erickson M. H., Rossi E. (1989), *The february man*, Brunner-Mazel, New York, (tr. it. *L'uomo di Febbraio. Lo sviluppo della coscienza e dell'identità nell'ipnoterapia*, Astrolabio, Roma, 1992).
- Gulotta G. (1997), *Lo psicoterapeuta stratega*, Franco Angeli, Milano.
- Haley J. (1963), *Strategies of psycoterapy*, Grune & Stratton, New York, (tr. it. *Le strategie della psicoterapia*, Sansoni, Firenze, 1997).
- Haley J. (1973), *Uncommon therapy*, Norton, New York, (tr. it. *Terapie non comuni. Tecniche ipnotiche e terapia della famiglia*, Astrolabio, Roma, 1976).
- Haley J. (1976), *Problem-Solving therapy. New strategies for effective family therapy*, Jossey-Bass, San Francisco, (tr. it. *La terapia del problem- solving. Nuove strategie per una terapia familiare efficace*, La Nuova Italia Scientifica, Firenze, 1985).
- Haley J. (1984), *Ordeal therapy. Unusual ways to change behavior*, Jossey-Bass, New York, (tr. it. *Il terapeuta e la sua vittima. L'uso dell'ordalia per cambiare il comportamento*, Astrolabio, Roma, 1985).
- Haley J. (1985), *Conversation with Milton Erickson Vol.I. Changing individuals*, Triangle Press, New York, (tr. it. *Cambiare gli individui. Conversazioni con Milton Erickson Vol. I.*, Astrolabio, Roma, 1987).
- Harré R. (1982), "Theoretical preliminaries to the study of action", in Von Cranach M., Harré R. (eds.), *The Analysis of Action*, Cambridge University Press, Cambridge, (tr. it. *L'analisi dell'azione*, Giuffrè, Milano, 1991).
- Harré R. (1993), *Social Being*, Blackwell, Oxford, (tr. it. *L'uomo sociale*, Cortina, Milano, 1994).
- Harré R., Gillet G. (1994), *The Discorsive Mind*, Sage, London, (tr. it. *La mente discorsiva*, Cortina, Milano, 1996).

- Nardone G. (1991), *Suggestione, Ristrutturazione, Cambiamento*, Giuffrè, Milano.
- Nardone G., Watzlawick P. (1990), *L'arte del cambiamento. Manuale di terapia strategica e ipnoterapia senza trance*, Ponte delle Grazie, Firenze.
- Petruccelli F., Parziale M. (1999), "Tecniche d'intervento in psicologia strategica", *Quale psicologia*, 13: 13-31.
- Schein E. H. (1987), *Process Consultation*, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, (tr. it. *Lezioni di Consulenza*, Raffaello Cortina, Milano, 1992).
- Smorti A. (2003), *La psicologia culturale. Processi di sviluppo e comprensione sociale*, Carocci, Roma.
- Von Cranach M., Harré R. (1982), *The Analysis of Action*, Cambridge University Press, Cambridge, (tr. it. *L'analisi dell'azione*, Giuffrè, Milano, 1991).
- Von Cranach M., Ochsenein G. (1994), *Agire. La forma umana del comportamento*, Il Mulino, Bologna.
- Von Cranach M., Valach L. (1983), "Theory of action", in Harré R., Lamb R. (eds.), *The Encyclopedic Dictionary of Psychology*, Oxford, Blackwell, (tr. it. *Psicologia. Dizionario enciclopedico*, Laterza, Roma-Bari, 1986).
- Watzlawick P. (1965), Paradoxical Predictions. *Psychiatry*, 28: 368-374.
- Watzlawick P., Beavin J., Jackson D.D. (1967), *Pragmatics of human communication. A study on interactional patterns, pathologies and paradoxes*, W.W. Norton and Co., New York, (tr. it. *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma, 1971).
- Watzlawick P., Weakland J. H., Fisch R. (1974), *Change, Principles of Problem Formation and Problem Resolution*, W. W. Norton and Co., New York, (tr. it. *Change, La formazione e la soluzione dei problemi*, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1978).

